CLÍNICA MUV · PARA MAQUETAR

SEDE TRES CANTOS · FISIOTERAPIA DE RODILLA

*Este documento es **solo para maquetar**: trae el texto exacto que va a la web, los encabezados y las notas de maquetación. Nada más.*

- **URL:** `/sedes/tres-cantos/fisioterapia-rodilla`
- **Encabezados:** 1 H1 + 9 H2 + 21 H3 · 8 preguntas frecuentes. El municipio va en el H1 y en un H2, y en ningún H3. Van tal cual: no se reformulan, no se reordenan y no se les añade el municipio.

Title

`Fisioterapia de rodilla en Tres Cantos: menisco y LCA | MUV`

Meta description

`Menisco, LCA, rótula y tendinitis rotuliana: fisioterapia y rehabilitación de rodilla en Tres Cantos, con o sin operación. Pida cita en MUV.`

> **Estado: borrador.** Lo marcado **en rojo** es un dato que MUV todavía no ha facilitado: **no se maqueta, no se rellena con algo parecido y no se inventa.** Si un bloque depende de un dato rojo, ese bloque espera. La página no se publica en producción hasta que contenidos lo confirme.

⚠ Esta página tiene 3 datos pendientes

Módulo	Qué falta
Qué tratamos	**confirmar con el fisioterapeuta que atiende artrosis de rodilla. Mientras no se confirme, este bloque no se publica**
Quién le atiende	**formación del fisioterapeuta, y foto con su permiso**
Dónde estamos y cuándo abrimos	**aparcamiento, accesibilidad de la entrada y transporte**

Todo lo de esta tabla aparece también en rojo dentro de su módulo.

Módulo 1 · Hero

H1

> Fisioterapia de rodilla y lesiones de rodilla en Tres Cantos

Entradilla

> ¿Le duele la rodilla al subir escaleras, al correr o al levantarse de la silla? En MUV Tres Cantos hacemos fisioterapia de rodilla: valoramos su caso, le explicamos qué le pasa y trabajamos con usted hasta que vuelve a confiar en ella. Primero el dolor, después la fuerza y, si es lo que busca, el deporte.

Lo esencial

> - Tratamos dolor femoropatelar, tendinopatías, meniscos, ligamentos —incluido el LCA— y la recuperación tras una operación.
> - El ejercicio y la fuerza son el centro. Las demás técnicas lo complementan.
> - Utilizamos ecografía y, como complemento, neuromodulación ecoguiada, cuando la valoración lo indica.
> - Una sola persona, fisioterapeuta colegiado, le acompaña durante todo el proceso.

Botones

> `[Pedir cita]` · `[Dónde estamos]` *(ancla al módulo 10)*

Módulo 2 · Qué tratamos

Eyebrow: Motivos de consulta

H2

> Lesiones y dolores de rodilla que tratamos en Tres Cantos

Entradilla

> Casi nadie llega sabiendo cómo se llama su lesión: llega sabiendo dónde le duele y cuándo.

H3 · Dolor delante de la rodilla: síndrome femoropatelar y condromalacia

> Dolor alrededor o detrás de la rótula al subir escaleras, ponerse en cuclillas, correr o tras un rato sentado. Es muy frecuente, también sin hacer deporte. El consenso internacional de 2018 recomienda empezar por ejercicio de cadera y de rodilla.

H3 · Tendinitis o tendinopatía rotuliana y del cuádriceps

> Dolor justo debajo o encima de la rótula al saltar, correr o hacer sentadillas. El tendón se irrita cuando la carga supera lo que tolera, y mejora enseñándole a tolerar más, poco a poco.

H3 · Menisco

> Los meniscos amortiguan la rodilla. Pueden lesionarse por un giro brusco o por desgaste. Provocan dolor en el interior o el exterior de la rodilla, chasquidos y, a veces, bloqueos. No todas las roturas necesitan operación: lo explicamos más abajo.

H3 · Ligamentos y rotura del ligamento cruzado anterior (LCA)

> El ligamento cruzado anterior se rompe sobre todo en giros y frenadas. Si hay rotura, la decisión de operar la toma usted con su traumatólogo. Lo que depende de la rehabilitación es cómo se recupera la fuerza y cuándo se vuelve al deporte.

H3 · Artrosis y dolor persistente de rodilla

> Dolor y rigidez que empeoran al ponerse en marcha y que duran meses. Para la artrosis, la guía NICE recomienda ofrecer ejercicio terapéutico adaptado a cada persona y plantea considerar sesiones supervisadas. Es normal notar más molestia al empezar: se empieza con poca carga y se sube despacio. `[PENDIENTE MUV: confirmar con el fisioterapeuta que atiende artrosis de rodilla. Mientras no se confirme, este bloque no se publica]`

H3 · Rehabilitación tras una operación de rodilla

> Tras una artroscopia, una cirugía de menisco o una reconstrucción del LCA, la rodilla debe volver a moverse, cargar y confiar. Si le han operado, traiga el informe y las indicaciones de su cirujano: la rehabilitación parte de ahí.

Módulo 3 · Cómo trabajamos

H2

> Rehabilitación de rodilla: de la valoración a la vuelta a la actividad

H3 · 1. Valoramos

> Hablamos de qué le pasa y qué movimientos le duelen. Exploramos la rodilla, la cadera, el tobillo y la fuerza de las piernas, porque el origen no siempre está donde duele. Cuando está indicado, miramos el tendón o la articulación con ecografía.

H3 · 2. Calmamos el dolor

> El objetivo es que la rodilla pueda moverse y cargar. Aquí entran las técnicas guiadas con ecografía, siempre como apoyo del ejercicio.

H3 · 3. Recuperamos fuerza y control

> Es la fase central: cuádriceps, isquiotibiales, glúteo y gemelo, y control del movimiento al aterrizar, girar y frenar. También hay clases de entrenamiento funcional supervisado en Tres Cantos.

H3 · 4. Volvemos a la actividad

> Primero a la vida diaria y, si es su objetivo, al deporte. La vuelta se decide por criterios —dolor controlado, movilidad completa, fuerza y capacidad de soportar la carga— y no solo por una fecha.

Módulo 4 · Técnicas

H2

> Técnicas de fisioterapia que utilizamos para la rodilla

Entradilla

> En la rodilla, el ejercicio es el centro del plan. El resto se suma solo si la valoración lo justifica. Cada técnica se explica entera en la página de fisioterapia deportiva y readaptación.

H3 · Ejercicio terapéutico y fuerza

> Es la base que recomiendan el consenso sobre el dolor femoropatelar y la guía NICE de artrosis. Se parte de una carga que usted tolere y se sube de forma progresiva.

H3 · Ecografía musculoesquelética

> Enseña al momento el estado del tendón y del líquido de la articulación, y ayuda a colocar con precisión otras técnicas. Complementa las pruebas de su médico; no las reemplaza.

H3 · Neuromodulación percutánea ecoguiada

> En la rodilla se utiliza como complemento del ejercicio, cuando la valoración lo indica. Es una técnica reciente y la investigación todavía es limitada.

Módulo 5 · ¿Operación o ejercicio?

H2

> ¿Operación o ejercicio? Lo que dice la investigación sobre el menisco

H3 · Menisco: una comparación entre cirugía y ejercicio

> Un ensayo clínico noruego, publicado en el *BMJ* en 2016, comparó dos opciones en 140 adultos de unos cincuenta años. Todos tenían una rotura de menisco por desgaste y no tenían artrosis evidente. A unos les asignó doce semanas de ejercicio supervisado y a otros, una artroscopia. A los dos años no había diferencias relevantes en la función de la rodilla. El grupo de ejercicio ganó fuerza en el muslo antes, y casi una de cada cinco personas de ese grupo acabó operándose.
>
> No significa que nadie deba operarse. Hay roturas en las que la cirugía puede ser lo mejor, sobre todo las de un giro brusco o las que bloquean la rodilla. La decisión es de su traumatólogo.

H3 · LCA: por qué se vuelve por criterios y no por fechas

> Un estudio de seguimiento siguió a 106 personas que practicaban deportes con giros. Hubo menos nuevas lesiones de rodilla en quienes retrasaban la vuelta hasta los nueve meses desde la operación. Lo mismo ocurrió

> en quienes volvían con la fuerza del cuádriceps más simétrica entre las dos piernas.

Módulo 6 · Quién le atiende

H2

> Quién le atiende

> MUV Tres Cantos es un **centro sanitario** inscrito en la Comunidad de Madrid (**CS 21018**). Su fisioterapeuta es **José Luis González Coronado**, colegiado nº 15502 y responsable de la clínica. Él valora su rodilla, la trata y trabaja con usted en la rehabilitación. `[PENDIENTE MUV: formación del fisioterapeuta, y foto con su permiso]`

Módulo 7 · Consejos y mitos

Eyebrow: Mientras tanto

H2

> Tres consejos para su rodilla y tres mitos

H3 · Muévase, pero dosifique

> El reposo prolongado rara vez ayuda. Mueva la rodilla con una carga que tolere y súbala poco a poco.

H3 · Fortalezca muslos y caderas

> Los músculos que sostienen la rodilla son el punto de partida de casi todos los planes.

H3 · Avise si el dolor va a más

> Una molestia leve que desaparece en un día suele ser tolerable. Si crece, le cambia la forma de andar o persiste, consúltenos antes de seguir.

H3 · Mito: «Con una rotura de menisco hay que operarse siempre»

> No siempre: en roturas por desgaste, el ejercicio supervisado dio resultados muy parecidos a la cirugía a los dos años.

H3 · Mito: «El reposo cura el tendón»

> No. En la tendinopatía rotuliana, la estrategia conservadora más estudiada son los programas de carga progresiva, no el reposo.

H3 · Mito: «Una rodillera lo arregla»

> El consenso internacional de 2018 recomienda el ejercicio como base y reconoce incertidumbre sobre los vendajes y las rodilleras.

Módulo 8 · Cuándo consultar antes con su médico

H2

> Cuándo conviene consultar antes con su médico

Entradilla

> Estas señales no son habituales, pero piden otra puerta de entrada: su médico o urgencias.

> - Hinchazón intensa en pocas horas tras un golpe o un giro.
> - Rodilla bloqueada, que no se estira del todo o que falla al apoyar.
> - Imposibilidad de apoyar la pierna.
> - Enrojecimiento y calor en la rodilla, con fiebre.
> - Dolor nocturno o en reposo que no mejora cambiando de postura.
> - Pantorrilla dolorida, hinchada o caliente.

Módulo 9 · Preguntas frecuentes

Eyebrow: Dudas habituales

H2

> Preguntas frecuentes sobre la fisioterapia de rodilla

¿Qué tipo de fisioterapia se recomienda para el dolor de rodilla?

> Depende de la causa, pero casi siempre el centro es el ejercicio: fuerza de muslos y caderas, control del movimiento y carga progresiva, con otras técnicas de apoyo.

¿Cuántas sesiones necesito?

> Depende de qué le pasa, desde cuándo y de su actividad. Tras la valoración se concreta un plan.

¿Qué ejercicios debo evitar con una rotura de menisco?

> Depende del tipo de rotura. Hasta que la valoremos, evite lo que le provoque dolor intenso, bloqueo o fallos. Por ejemplo, girar sobre la pierna apoyada o ponerse en cuclillas profundas.

¿Cómo se rehabilita el síndrome femoropatelar?

> Con ejercicio: una combinación de cadera y rodilla, con una carga que sube poco a poco. Suele llevar semanas, no días.

¿Cuánto dura la rehabilitación del LCA?

> Depende de si ha habido operación y de cada persona. Se trabaja por criterios, no por fechas, porque volver demasiado pronto se asocia a más nuevas lesiones.

¿Es bueno caminar con una tendinitis rotuliana?

> Moverse suele ayudar más que parar del todo. Conviene dosificar los saltos, las sentadillas profundas y las bajadas. Si el dolor aumenta, consúltenos.

¿Necesito una resonancia para empezar?

> No para empezar la valoración. Si ya tiene pruebas de imagen o informes, tráigalos. La ecografía complementa la exploración y no sustituye a las pruebas que indique su médico.

¿Cuándo empiezo la rehabilitación si me han operado?

> Depende de la operación, y lo marca su cirujano. Traiga el informe y sus indicaciones a la primera cita: la rehabilitación parte de ahí.

Módulo 10 · Dónde estamos y cuándo abrimos

H2

> Dónde estamos y cuándo abrimos

Ficha de contacto

> **MUV Tres Cantos** · Av. de Madrid, 19, Loc 5 · 28760 Tres Cantos
>
> **Horario:** de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00; los sábados, de 9:00 a 14:00. Los domingos cerramos.
>
> **Teléfono:** 614 13 14 05
>
> `[PENDIENTE MUV: aparcamiento, accesibilidad de la entrada y transporte]`

Cómo llegar

> Encontrará cómo llegar, el aparcamiento y la accesibilidad en la página de MUV Tres Cantos.

Botón

> `[Pedir cita para valorar su rodilla]`

Enlaces internos del texto

Módulo	Texto del enlace	Destino
Cómo trabajamos	entrenamiento funcional supervisado en Tres Cantos	`/sedes/tres-cantos/entrenamiento-funcional`
Técnicas	fisioterapia deportiva y readaptación	`/sedes/tres-cantos/fisioterapia-deportiva`
Dónde estamos y cuándo abrimos	MUV Tres Cantos	`/sedes/tres-cantos#como-llegar`

Fuentes (pie de la página, en letra pequeña)

1. Collins NJ et al. *2018 Consensus statement on exercise therapy and physical interventions to treat patellofemoral pain.* Br J Sports Med 2018. PMID 29925502.
2. Kise NJ et al. *Exercise therapy versus arthroscopic partial meniscectomy for degenerative meniscal tear in middle aged patients.* BMJ 2016. PMID 27440192.
3. Logerstedt DS et al. *Knee Pain and Mobility Impairments: Meniscal and Articular Cartilage Lesions, Revision 2018.* JOSPT 2018. PMID 29385940.
4. Malliaras P et al. *Achilles and patellar tendinopathy loading programmes.* Sports Med 2013. PMID 23494258.
5. Grindem H et al. *Simple decision rules can reduce reinjury risk after ACL reconstruction.* Br J Sports Med 2016. PMID 27162233.
6. NICE. *Osteoarthritis in over 16s: diagnosis and management (NG226).*

Datos pendientes de la clínica (lista completa)

Lo que contenidos está pidiendo a los dueños. Mientras no llegue, lo que dependa de ello **no se maqueta ni se rellena**.

Dato	De quién
¿Atiende artrosis de rodilla? Hasta que lo confirme, el bloque de artrosis no se publica	Fisioterapeuta de Tres Cantos
¿Atiende rehabilitación tras una prótesis de rodilla o una sutura de menisco? La competencia las publica y no se escriben sin confirmación	Fisioterapeuta de Tres Cantos
Formación del fisioterapeuta, en rodilla en concreto, y foto con su permiso	Dueño de Tres Cantos
Aparcamiento, accesibilidad y transporte	Dueño de Tres Cantos
Revisión clínica de consejos, mitos y señales de alarma	Fisioterapeuta de la clínica

Notas de maquetación

- **Enlazado:** el módulo 4 enlaza a `/sedes/tres-cantos/fisioterapia-deportiva`; el módulo 10 a `/sedes/tres-cantos#como-llegar`. La página de sede debe enlazar a esta con «fisioterapia de rodilla en Tres Cantos» en el ancla.
- **Marcado:** `BreadcrumbList`, `FAQPage` (las 8 preguntas, todas con respuesta publicada) y el servicio con `provider` apuntando al `@id` del `MedicalClinic` de la sede. Nada de `aggregateRating`, nada de `areaServed`.
- **ALT de las imágenes:** pendientes de elegir las fotos de la galería de Tres Cantos. Cada ALT con la entidad y el municipio, sin repetir el del H1.
- **Cita:** el botón abre el selector de sede ya existente.